

УДК: 616-444-006.6: 615.277-036.8

Р.К. Каракулов, С.Т. Габбасова, Р.М. Рамазанова., Г.А. Сагиндыков, Б.А. Насипов, А.С. Джазылтаева,
Г.К. Смагулова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы

Эффективность режима Бортезомиб + СНОР и цитогенетические параметры у пациентов с рецидивами индолентных лимфом

Аннотация. У 6 пациентов с рецидивами НХЛ II-IV стадий лечение проводилось с применением режима Бортезомиб+СНОР21. Всего проведено 4-6 курсов ПХТ. Предварительные результаты исследования показывают, где пациенты получали ПХТ по схеме Бортезомиб+СНОР 21 полная ремиссия процесса достигнута у 3-х больных, частичная - у 2-х пациентов, прогрессирование процесса - у 1 больного.

Ключевые слова: неходжкинские лимфомы, рецидивы, бортезомиб+СНОР, ремиссия.

За последние десятилетия отмечается значительный рост заболеваемости неходжкинскими лимфомами (НХЛ) во всем мире. Согласно современной классификации International Lymphoma Study Group и Всемирной организации здравоохранения, НХЛ представляют собой большую группу гематологических заболеваний, характеризующихся разнообразными гистологическими, иммунологическими, молекулярно-генетическими и клиническими проявлениями [2,4].

В Республике Казахстан злокачественные лимфомы в структуре онкопатологии занимают 8 ранговую позицию, составляя 4,2 на 100 000 населения [1].

Известно, что индолентные лимфомы составляют около 60% из всех лимфом, пятилетняя выживаемость при В-клеточных лимфомах не превышает 70,0% [3,5].

Цель исследования: изучение эффективности нового режима ПХТ Бортезомиб + СНОР в лечении рецидивов индолентных форм НХЛ и их цитогенетических параметров.

Дизайн исследования: Проводилось лечение 6 пациентов с рецидивами НХЛ низкой степени злокачественности II-IV А и В стадий заболевания. Возраст пациентов колебался от 40 до 73 лет.

Критерий включения: предлеченные больные с рецидивами индолентных форм НХЛ II-IV А и В стадий, верифицированные гистологическими и ИГХ исследованиями, в возрасте до 80 лет.

Критерий исключения: пациенты в возрасте свыше 80 лет и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печеночной и почечной недостаточностью и сахарным диабетом.

Задачи исследования: изучение эффективности нового режима – Бортезомиб плюс СНОР при рецидивах НХЛ и цитогенетических параметров опухоли.

Все пациенты ранее получали 4-6 курсов ПХТ по схемам R-СНОР и в течение 6-8 мес. от начала лечения зарегистрированы рецидивы заболевания.

В основной группе у 6 пациентов со рецидивами НХЛ

II-IV стадий лечение проводилось с применением режима Бортезомиб+СНОР 21 (бортезомиб 1,3 мг/м² в 1, 4, 8, 11 дни, циклофосфамид 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², все 1 день, преднизолон 40 мг/м² с 1-5 дни), цикл повторяли через каждые 21 день. Всего проведено 6-8 курсов ПХТ. Гистологические варианты были представлены в виде фолликулярной лимфомы - 3 больных, мантийной зоны - 2 больных и диффузнокрупноклеточная В-клеточная лимфома - 1 больной, во всех случаях был экспрессирован CD 20 антиген, Ki 67 у всех больных варьировал от 45 до 70%, т.е. имели среднюю пролиферативную активность.

Предварительные результаты исследования показывают, где пациенты получали ПХТ по схеме Бортезомиб+СНОР 21 полная ремиссия процесса достигнута у 3-х больных, частичная - у 2-х пациентов, прогрессирование процесса - у 1 больного (таблица 1).

Пациенты в целом лечение переносили удовлетворительно, однако у 2-х больных из 4 зарегистрирована периферическая нейропатия, из общего анализа крови отмечались умеренная нейтропения.

Таблица 1 - Результаты лечения больных с НХЛ при применении схемы Бортезомиб+СНОР

Группа больных	Полная ремиссия	Частичная ремиссия	Прогрессирование
Бортезомиб+СНОР21 n=6	3 больных (50%)	2 больной (30%)	1 больной (20%)
СНОР 21 n=10	4 больных (40%)	4 больных (40%)	2 больных (20%)

В контрольную группу (исторический) (n=10) были включены пациенты, получавшие ПХТ по протоколу СНОР 21. При этом полная ремиссия процесса была установлена только у 5 (50%) больных, частичная ремиссия - у 3-х, а у 2 больных зарегистрирован продолженный рост опухоли. Общая пятилетняя выживаемость после 6-8 курсов лечения в этой группе составляет всего 60%.

Материалом цитогенетического и молекулярно-генетического исследований служил биопсийный материал. Анализ типов хромосомных aberrаций (ХА) проводили в соответствии с международной номенклатурой. Выявленные в результате цитогенетического исследования хромосомные aberrации не являлись специфическими и не носили клональный характер. Отмечалось повышенное процентное содержание полиплоидных клеток.

Пациенты лечение переносили удовлетворительно, у 3-х больных из 5 зарегистрирована периферическая нейропатия, из общего анализа крови отмечались умеренная нейтропения.

Пример 1. Больной С. 61 лет, клинический диагноз: НХЛ из мантийной зоны, ст.IIB, наблюдается 1 год, ранее было проведено 6 курсов ПХТ по схеме СНОР, ремиссия не была достигнута. В связи с прогрессированием заболевания больному было проведено 6 курсов ПХТ по схеме Бортезомиб+СНОР, отмечается полная регрессия процесса. Больной продолжает получать лечение.

Пример 2. Пациент Э. 62 лет наблюдается 2 года по поводу НХЛ, крупноклеточной внутрисосудистой, ст IIB, до этого больной получал 8 курсов ПХТ по схеме R-СНОР 21, ремиссия составила 1,5 года. Далее в связи с рецидивом процесса больной был переведен на схему Бортезомиб+СНОР, получил 3 курса и зарегистрирована полная ремиссия процесса. У 3-х пациентов из 6 отмечалось периферическая нейропатия, которая была купирована после специального лечения.

Как видно из таблицы 2 показатели красной крови у пациентов основной группы после лечения значительно возрастают за счет регрессии опухолей и купирования симптомов интоксикации, в то же время в контрольной группе таковое было выражено меньшей степени, хотя различия между сравниваемыми группами мало достоверны. Лейкоцитоз отмечался до лечения в основной и контрольных группах, но снижение такового было существенным в основной группе. В обеих группах после лечения отмечается незначительное снижение общего количества тромбоцитов, но различия незначительные. В основной группе после ПХТ СОЭ снизилась в 3 раза по сравнению с контрольной группой. У больных имелись симптомы нейропатии в виде покалывания кончиков пальцев рук и ног и появления периодического болевого синдрома.

Таблица 2 - Гематологическая токсичность ПХТ в основной и контрольной группах у больных с НХЛ

Показатели	Основная группа (Бортезомиб +СНОР 21)		Контрольная группа (СНОР 21)	
	До лечения	После 6 курсов	До лечения	После 6 курсов
Гемоглобин, г/л	95,0	110,0	80,0	105,0
Эритроциты, млн	3,2	4,6	3,5	4,7
Лейкоциты, тыс.	10,8	3,0	8,9	3,5
Тромбоциты, тыс.	233	180	214	110
СОЭ, мм/час	65	18	52	25
Лимфоциты, %	38	20	36	17
Сегментоядерные	80	48	86	53

Установлено, что до лечения у пациентов с НХЛ в основной и контрольной группах существенно страдают белковообразовательная и детоксикационная функции печени. У пациентов до лечения отмечается гипопропротеинемия, которая после лечения в основной и контрольной группах одинаково повышается в среднем на 10 г/л. Показатели АсТ, АлТ, общего билирубина и креатинина были достаточно высокими, после лечения таковые снижаются в среднем в 3 раза по сравнению с контрольной группой, а такие показатели биохимического анализа крови как ЛДГ и щелочная фосфатаза падают в пределах 2-3 раза по сравнению их с первоначальными показателями ($p=0,05$).

Таким образом, можно полагать, что применение модернизированной схемы ПХТ (Бортезомиб+СНОР) не оказывает существенного токсического действия на организм больных.

Пациенты лечение переносили удовлетворительно, у

3-х больных из 5 зарегистрирована периферическая нейропатия, из общего анализа крови отмечались умеренная нейтропения.

Так как в результате цитогенетических исследований специфических хромосомных маркеров, характерных НХЛ, выявлено не было, планируется проведение более чувствительного молекулярно-цитогенетического метода исследования (FISH) на парафинизированном биопсийном материале.

Таким образом, предварительные результаты лечения больных с рецидивами индолентных форм НХЛ показывает перспективность режима Бортезомиб плюс СНОР-21 по сравнению со схемой СНОР. Безопасность режима была удовлетворительная. Изучение цитогенетических данных показало об отсутствии специфических хромосомных маркеров, характерных для НХЛ.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Махатова А.Г. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год. - Алматы, 2012.
2. H. Stein, R.A. Warnke, W.C. Chan et al. Diffuse large B-cells lymphoma, not otherwise specified // WHO Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 4th Ed. - Lyon, 2008.
3. Короленко В.О., Гэршанови М.Л. Трехлетние результаты применения Мабтеры (Ритуксимаб) в лечении индолентных неходжкинских лимфом, резистентных к стандартной химиотерапии // Вopr. онкологии. - 2004. - Т.50, №4. - С.421- 425.
4. Hiyama H. Telomerase activity in small-cells and non-small-cells lung cfncers // J. Natl. Cancer Inst. - 2010. - Vol.87. - С.895.
5. Гоанов А.Н., Ильин Н.Е. Лимфомы. - С-Пб, 2010.

Тұжырым

Р.К. Каракулов, С.Т. Габбасова, Р.М. Рамазанова, Г.А. Сагиндыков, О.В. Ниетпаева, Б.А. Насипов, А.С. Джазылтаева, Г.К. Смагулова.

Лимфоманың индолентті түрінде Бортезомиб+СНОР кестесінің әсері және цитогенетикалық параметрлері

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Лимфоманың индолентті түрінде Бортезомиб+СНОР кестесінің әсері және цитогенетикалық параметрлері Ходжкин емес лимфоманың қайта қозған түрін Бортезомиб+СНОР кестесі бойынша ем шара жасалғанда, 1 науқастың - толық ремиссия, 2 - жартылай ремиссия байқалды, ал 1 науқаста аурудың асқынуы байқалды.

Түйінді сөздер: жедел лейкоз, морфоцитохимиялық классификациясы.

Summary

R.K. Karakulov, S.T. Gabbasova, R.M. Ramazanova., G.A. Sagindykov, B.A. Nasipov, A.S. Dzhasyltaeva, G.K. Smagulova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

In 6 patients with relapsed NHL stages II-IV treatment was carried out with the use of bortezomib + CHOP 21 mode. A total of 4-6 courses of chemotherapy. Preliminary results show that patients, who were treated with scheme Bortezomib + CHOP 21 achieved complete remission- 3 patients, partly - 2 patients, progression of the process - 1 patient.

Application mode Rituximab Plus CHOP for aggressive non-Hodgkin lymphoma.

Keywords: non-Hodgkin's lymphoma, relapse, bortezomib + CHOP, remission.